

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA NEUROPSICOLOGÍA						
	Historia # 00002				Fecha De Impresión: 18-11-2025 18:01:55		
Datos Personales							
Nombre:	JUAN MANUEL MARÍN CAMPO	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2011-12-19	Edad	13 Años, 10 Meses, Y 30 Días
Identificación:	TI - 1066290502	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	MCAMCAN1013@GMAIL.COM - 1066290502			Dirección:	MZ 4 CASA 41 URB. RAFAEL ESCALONA		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		MELBA ALICIA CAMPO CANTILLO - Parentesco (madre)					

Apertura Neuropsicología del 2025-06-11 17:42:06: 13 años, 10 meses, y 30 días

DATOS GENERALES

Código de consulta

No se ha seleccionado un código de consulta

Motivo de consulta

Madre refiere “le han aplicado dos veces pruebas, queremos mirar el tema de la atención, a veces se le dificulta que se distrae”

Enfermedad actual

Paciente con cuadro de evolución desde los 7 años caracterizado por algunas quejas escolares por distraerse, levantarse del puesto, comenzó proceso de rehabilitación aproximadamente de 7 – 8 años con psicología, fonoaudiología (fonoaudiología refirió que todo estaba bien), se abordaba con la educadora especial tareas y temas relacionados de atención, actualmente presenta distractibilidad en materias que poco le motivan como lenguaje, filosofía, sociales, competencias, rendimiento básico en estas materias, hace tres años fue cambiado de institución educativa (antes estudiaba en Bosconia), el rendimiento académico era ajustado a las exigencias del plantel educativo. Le cuesta leer, le cuesta la comprensión lectora, debe leer varias veces para poder realizar las consignadas dadas en la lectura.

Estuvo medicado por psiquiatría infantil diagnosticado con trastorno mixto de ansiedad y depresión medicado con fluoxetina, sigue con la prescripción pero desde julio del 2024 no ingiere el medicamento.

Duerme a las 9 pm, se queda dormido a las 11 pm, en ocasiones se le restringe el celular, convive con la abuela, la madre labora en Bosconia, viene de forma frecuente a la ciudad los viernes, miércoles; madre lo describe como inmaduro, infantil.

Paciente refiere “En ocasiones siento que me estreso mucho (distrés), siento hipertensión en las venas, me palpitan las venas, muchas veces me pasa que mis amigos están hablando, quiero aportar pero no puedo, me quedo en blanco y no puedo hablar, siento que no puedo decir nada, no tengo literalmente nada en la cabeza, no vocalizo bien, me frustró demasiado”.

No come guineo verde, le da asco el calle (guineo verde con queso), por lo generalmente es inapetente, está bajo de peso, presenta pubertad precoz.

A los 7 años varios compañeros le decían que hiciera cosas, que diera elementos, lo cual hacia para encajar en grupos sociales. Mantiene una inadecuada posición sedente en silla, tiende a ser desordenado, tira las cosas, el cepillo de dientes lo tira, es un poco brusco, le cuesta terminar por ejemplo la rutina de cambiado cuando va al colegio, lo hace de forma desorganizada, tarda más de lo habitual en ejecutar las acciones o tareas.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

No Reporta,NO REPORTA

Traumáticos

Otro

Medicación

No Reporta

Paraclínicos

No Reporta,NO REPORTA

Hospitalizaciones

No Reporta

Patología

No Reporta

Tóxicos

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo

NA

Enfermedades De La Madre

No

Único Embarazo

1

El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica

Si

Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo

Si

Estado De La Madre Durante El Embarazo

Eutímica

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Riesgo
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 3000 Kg
Talla Al Nacer 59 Cm	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES Posnatales	
Hospitalizaciones Recién Nacido No Reporta	Desarrollo Psicomotor POSNATALES: Control Cefálico 2 Meses, Rolado 3 Meses, Sentado 6 Meses, Gateo 8 Meses- Patrón Reciproco, Bipedestación 11 Meses, Marcha 12 Meses, (si) Reacción A Los Sonidos, (si) Fijación De La Mirada, Lenguaje Funcional, Reporte Peso Al Nacer 3000 Kg, Reporte De Talla Aproximado 59 Cm.

ANTECEDENTES Desarrollo Psicomotor	
Control Cefálico 2	Rolado 3
Sedente Solo 6	Gateo 8
Bípodo Sin Ayuda 12	Marcha 11
Lenguaje Verbal 8 MESES	Lenguaje Verbal Fluido 30 MESES

ANTECEDENTES Médicos Familiares	
Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos NO REPORTA	Otros

Áreas de Ajuste y/o Desempeño
Historia educativa Paciente quien cursara decimo grado, en el presente año en el primer trimestre perdió filosofía y sociales, con rendimiento básico actualmente en materias que no le motivan. Persisten dificultades para concentrarse, quiere ser sociable pero se le dificulta.
Historia laboral NA
Historia familiar NA
Historia social NA
Historia socio-afectiva Inicia, mantiene y finaliza una interacción con otros. (si) Reconoce sentimientos. (si) Regular su propia conducta. (no) Controla sus impulsos. (no) Hace y mantiene relaciones de amistad y amor. (si) Se comporta en público de manera socialmente aceptable. (si) Termina las actividades que inicia. (si) Acepta los límites del adulto. (algunas veces) Cumple con normas de cortesía: por favor, gracias, permiso (si) Resuelve problemas y situaciones cotidianas. (si) Respeta los reglamentos deportivos y recreativos (si) Realiza trabajos sin depender de otros. (si) Se observan facies depresivas, en ocasiones se levanta si ganas de hacer nada, tendencia a la labilidad emocional, por momentos ansioso, le cuesta expresar sus ideas.

Interconsultas e Intervenciones
Intervención psiquiátrica Consulta
Intervención neurológica
Intervención neuropsicológica Neuropsicología

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

Paciente con adecuada presentación personal, inadecuada higiene postural, alerta, colaboradora, desorientado alo y orientada auto psíquicamente, algunos problemas en comprensión, baja tolerancia a la frustración, si, trastornos del lenguaje: dislalia leve, lenguaje fluido, no facilidad de contacto, juicio desviado, inteligencia aparentemente normal, pensamiento rígido.

Ciclos del Sueño

NA

Apetito

NA

Actividades de Autocuidado

NA

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F412 - TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

F606 - TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA)

Impresión Diagnóstica Relacionada 2

F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION

Establecido por primera vez

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Evaluación Neuropsicologica

Objetivos Especificos

Conocer perfil cognitivo

Sugerencias e Interconsultas

Observaciones y Recomendaciones

NA


Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096
U.S.B. - Medellín

DR. JAINER GUZMAN

Tarjeta Profesional: 123096